Mélanome test

Niveau : DES
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Mélanome test

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome est une tumeur maligne des mélanocytes, cellules responsables de la pigmentation cutanée. Il représente une entité oncologique d'une importance capitale en dermatologie en raison de sa gravité potentielle et de l'augmentation constante de son incidence à l'échelle mondiale (Dermatologie, 2022). Bien que les tumeurs cutanées épithéliales, telles que les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes, soient plus fréquentes, le mélanome se distingue par son potentiel métastatique élevé et sa mortalité significative s'il n'est pas diagnostiqué et traité précocement (Dermatologie, 2022). La compréhension de son épidémiologie, de ses facteurs de risque et des stratégies de prévention est donc fondamentale pour tout dermatologue, constituant un pilier essentiel de la prise en charge des patients.

I. Épidémiologie du Mélanome Cutané

Le mélanome cutané est la forme la plus courante de mélanome, bien qu'il existe également des mélanomes muqueux et uvéaux (Amaral et al., 2025). Son incidence est en progression constante dans de nombreuses régions du monde, ce qui en fait un problème de santé publique majeur.

A. Incidence et Prévalence

Les tumeurs cutanées représentent une part significative de la pathologie oncologique, et parmi elles, le mélanome est la tumeur mélanique la plus redoutée (Dermatologie, 2022). Bien que les données précises de prévalence et d'incidence globales ne soient pas explicitement détaillées pour toutes les régions dans les sources fournies, il est établi que le mélanome est une des principales familles de tumeurs cutanées à connaître (Dermatologie, 2022).

B. Facteurs de Risque

L'identification des facteurs de risque est cruciale pour la prévention primaire et secondaire du mélanome. Ces facteurs peuvent être classés en plusieurs catégories :

1. Facteurs Constitutionnels et Génétiques

Plusieurs caractéristiques individuelles augmentent le risque de développer un mélanome :

- **Phototype clair** : Les individus ayant une peau claire, une tendance à rougir plutôt qu'à bronzer, des cheveux roux, des yeux bleus et une forte propension aux taches de rousseur présentent un risque accru (NCCN, 2026 ; Dermatologie, 2022). Cette susceptibilité est liée à un phénotype à prédominance de phéomélanine (pigment jaune-rouge) par rapport à l'eumélanine (pigment brun-noir), indiquant une sensibilité

accrue au soleil (NCCN, 2026).

• **Antécédents personnels ou familiaux de mélanome** : Un antécédent personnel de mélanome est un facteur de risque majeur pour le développement d'un second mélanome primitif (Dermatologie, 2022 ; NCCN, 2026). Le risque de survenue d'un second mélanome primitif est un élément épidémiologique important à considérer (Dermatologie, 2022). De même, une histoire familiale de mélanome augmente la prédisposition (NCCN, 2026 ; Dermatologie, 2022). Des variants pathogènes germinaux ont été identifiés chez des individus atteints de mélanome, soulignant la composante génétique (Funchain et al., 2024 ; Lochrin et al., 2024).

• **Nævus mélanocytaires** : Un nombre élevé de nævus est un facteur de risque reconnu (Dermatologie, 2022). Le syndrome des nævus atypiques, caractérisé par la présence de multiples nævus dysplasiques, confère un risque particulièrement élevé et justifie un suivi dermatologique spécifique (Dermatologie, 2022). La définition, les facteurs de risque et les profils évolutifs des nævus sont des connaissances fondamentales (Dermatologie, 2022).

• **Âge et Sexe** : Un âge avancé et le sexe masculin sont associés à un pronostic plus défavorable (Garbe et al., 2025).

• **Localisation tumorale** : Les mélanomes situés sur le tronc, la tête et le cou ont un pronostic plus sombre que ceux des membres (Garbe et al., 2025).

2. Facteurs Environnementaux

L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le principal facteur environnemental impliqué dans la carcinogenèse du mélanome (Dermatologie, 2022).

• **Exposition solaire** : Le soleil est le principal facteur environnemental (Dermatologie, 2022). Les expositions intermittentes et les coups de soleil, en particulier ceux survenus durant l'enfance ou l'adolescence, sont fortement associés au risque de mélanome (Dermatologie, 2022 ; NCCN, 2026). Une étude prospective a montré que les coups de soleil bulleux multiples entre 15 et 20 ans étaient un indicateur d'exposition solaire précoce et étaient associés à certains sous-types de mélanome (superficiel extensif et nodulaire) (NCCN, 2026).

• **Exposition chronique au soleil** : D'autres sous-types de mélanome, comme le lentigo malin et le mélanome desmoplastique, qui apparaissent généralement sur des zones chroniquement photo-exposées, sont associés à une exposition solaire chronique et surviennent plus tard dans la vie (NCCN, 2026).

• **Rayons UV artificiels** : L'utilisation de cabines de bronzage (UV artificiels) est également un facteur de risque avéré (Dermatologie, 2022).

3. Antécédents Médicaux et Comorbidités

Certains antécédents médicaux augmentent la vulnérabilité au mélanome :

• **Antécédents de carcinomes non-mélaniques** : Les patients ayant des antécédents de carcinomes basocellulaires (CBC) et/ou épidermoïdes (CE) présentent un risque significativement accru de développer un mélanome (NCCN, 2026). Une étude a rapporté un risque relatif de 17 par rapport à une population témoin, suggérant un partage de facteurs de risque étiologiques liés aux UV (NCCN, 2026). Ces patients

nécessitent une surveillance cutanée annuelle pour la détection précoce de mélanomes curables (NCCN, 2026).

• **Antécédents de cancer infantile** : Les survivants de cancers infantiles ont un risque 2,5 fois plus élevé de développer un mélanome ultérieurement, soulignant l'importance du dépistage précoce et de la prévention dans cette population (NCCN, 2026).

• **Immunosuppression** : Les populations immunodéprimées, notamment celles atteintes du VIH/SIDA, les receveurs de greffes d'organes solides ou de cellules hématopoïétiques, présentent des taux plus élevés de mélanome et une réponse différente aux traitements (NCCN, 2026).

• **Génodermatoses rares** : Des maladies génétiques rares comme le Xeroderma Pigmentosum sont associées à un risque considérablement accru de mélanome (NCCN, 2026).

4. Types de Mélanome Non Liés aux UV

Il est important de noter que tous les mélanomes ne sont pas liés à l'exposition aux UV. Les mélanomes acraux (paumes, plantes, appareil unguéal) et les mélanomes muqueux ne sont pas associés aux rayonnements ultraviolets (NCCN, 2026). Ces formes cliniques, ainsi que les mélanomes hypomélaniques ou achromiques, peuvent présenter des défis diagnostiques particuliers (Ortiz, 2024 ; Dermatologie, 2022).

II. Histoire Naturelle et Physiopathologie

Le processus de cancérisation dans le cadre du mélanome implique une transformation maligne des mélanocytes (Dermatologie, 2022). Il est crucial de retracer l'histoire naturelle de ce processus (Dermatologie, 2022). La plupart des mélanomes naissent *de novo*, c'est-à-dire sur une peau saine, plutôt que de dériver de nævus préexistants (Dermatologie, 2022). Cependant, la connaissance des nævus et de leurs profils évolutifs est essentielle pour le diagnostic différentiel (Dermatologie, 2022).

III. Prévention du Mélanome

La prévention du mélanome repose sur deux piliers : la prévention primaire et la prévention secondaire (Dermatologie, 2022).

A. Prévention Primaire

La prévention primaire vise à réduire l'incidence du mélanome en agissant sur les facteurs de risque modifiables :

• **Information et éducation** : Informer la population sur les risques liés aux UV naturels (soleil) et artificiels (cabines à UV) est fondamental (Dermatologie, 2022).

• **Réduction des expositions** : Cela inclut la limitation des expositions durant les heures de fort ensoleillement, l'utilisation de protections vestimentaires adaptées et l'application répétée de photoprotecteurs externes sur les zones découvertes

(Dermatologie, 2022). Ces mesures sont particulièrement essentielles chez les enfants, mais restent importantes à tous les âges de la vie (Dermatologie, 2022).

B. Prévention Secondaire

La prévention secondaire vise à améliorer le pronostic par un dépistage précoce des lésions (Dermatologie, 2022).

- **Autosurveillance** :

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• cutaneous_melanoma

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up